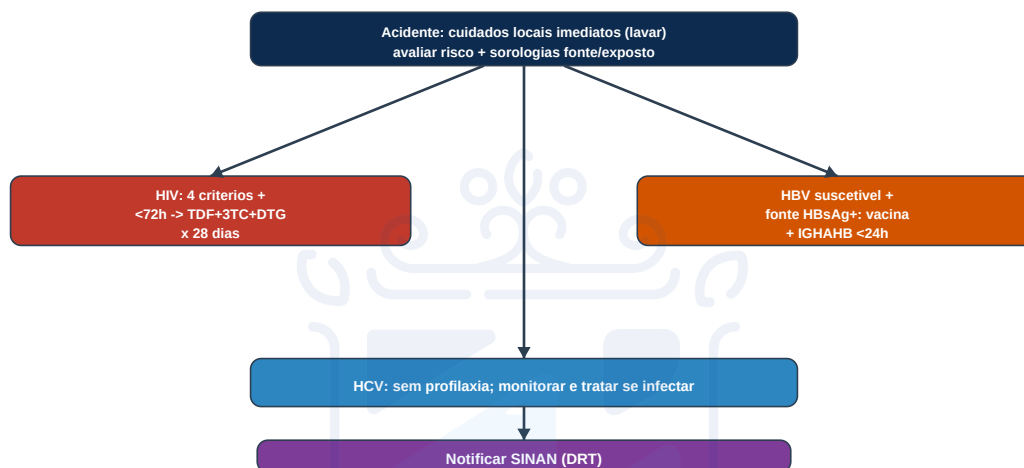


ACIDENTE BIOLÓGICO — PEP HIV/HBV EM 72h

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

ACIDENTE BIOLÓGICO — LAVAR -> AVALIAR -> PROFILAXIA



DEFINIÇÃO E MANEJO INICIAL

TRÊS MEDIDAS INICIAIS

- Contato do profissional com fluidos corporais no trabalho; principal risco: hepatite B, hepatite C e HIV
- 1) CUIDADOS LOCAIS: lavar a área com água e sabão (mucosas com água/SF); NÃO ampliar a lesão (cortes/injeções) nem usar substâncias irritantes (éter/hipoclorito)
- 2) AVALIAR O RISCO: tipo de exposição (percutânea/mucosa/pele não íntegra), tipo de fluido (sangue, sêmen, vaginal, cavitários — sangue é o maior risco), perfil sorológico fonte e exposto
- 3) NOTIFICAR ao SINAN (ficha de acidente de trabalho com material biológico)
- Exames de fonte e exposto: HBsAg, anti-HCV, teste rápido HIV; no exposto, também anti-HBs (suscetibilidade)

RISCO DE TRANSMISSÃO POR PATÓGENO

Vírus	Risco / fatores
HIV	~0,23% (perfurocortante); maior se lesão profunda, sangue visível no instrumento/inserido em vaso, fonte em fase avançada (carga viral alta)
Hepatite B	23-62% (o maior!); maior se fonte HBeAg positivo
Hepatite C	~2,2%; profundidade da lesão é fator de risco; SEM profilaxia disponível

PEP PARA HIV

Rx 4 CRITÉRIOS + < 72h

Indicar PEP se TODOS os 4 critérios: exposição de risco + material de risco + exposto SUSCETÍVEL (teste rápido negativo) + intervalo < 72h

Esquema preferencial: TENOFOVIR + LAMIVUDINA + DOLUTEGRAVIR (TDF + 3TC + DTG) por 28 DIAS — iniciar o mais precocemente possível

Tenofovir: evitar em doença renal; cautela na hepatite B (risco de exacerbação ao suspender)

Fonte desconhecida/indisponível: PEP geralmente recomendada (individualizar pela gravidade e probabilidade de a fonte ter HIV)

Exposto com teste rápido POSITIVO: avaliar diagnóstico de HIV (2º teste) e iniciar TARV, não PEP; se > 72h e teste negativo: NÃO indicar PEP (acompanhar sorologia em 1 e 3 meses)

Reavaliar em 4 semanas; efeitos comuns (náusea, diarreia, cefaleia, fadiga) — manejo sintomático; repetir teste HIV em 1 e 3 meses, mantendo preservativo até excluir infecção

PROFILAXIA — HEPATITE B E MANEJO DA HEPATITE C

Rx VACINA + IMUNOGLOBULINA

Imune (anti-HBs $\geq$ 10 mUI/mL ou hepatite B prévia): NENHUMA medida adicional

Suscetível (anti-HBs e HBsAg não reagentes): VACINA (1ª dose preferencialmente em 24h, completar esquema) — reduz ~75% do risco; indicada se vacinação ausente/incompleta ou sem soroconversão

IGHAHB (imunoglobulina) 0,06 mL/kg IM (em membro diferente da vacina, idealmente < 24h, até 7 dias): exposto suscetível com esquema incompleto/sem resposta E fonte HBsAg+ (ou fonte desconhecida de alto risco)

Não respondedor após 2 esquemas: 2 doses de IGHAHB com 1 mês de intervalo (não revacinar)

HEPATITE C: NÃO há profilaxia; testar fonte e exposto para diagnóstico/tratamento precoce (cura > 95%); monitorar o exposto se fonte reagente/desconhecida (ou fonte negativa com exposição de risco recente — janela até ~129 dias)

Pré-exposição: vacinação contra hepatite B de todos os profissionais (3 doses + anti-HBs)

ACOMPANHAMENTO E NOTIFICAÇÃO

SEGUIMENTO

- ☐ PEP HIV: retorno em 4 semanas (ou antes se sintomas); sintomas de síndrome mono-like -> pesquisar infecção aguda pelo HIV
- ☐ Repetir teste HIV em 1 e 3 meses; manter medidas preventivas (preservativo) até a exclusão definitiva
- ☐ Hepatite C: monitorização sorológica/molecular conforme exposição (fonte reagente/desconhecida ou janela)
- ☐ Notificação compulsória do acidente de trabalho (SINAN)
- ☐ Reforçar prevenção: EPI, perfurocortantes com dispositivo de segurança, educação, vacinação contra hepatite B

MODELO DE REGISTRO / ENCAMINHAMENTO

RESUMO DO ACIDENTE

- Profissional ____; tipo de exposição ____ (percutânea/mucosa/pele não íntegra); fluido ____; tempo desde a exposição ____ h.
- Sorologias — fonte: HBsAg ____, anti-HCV ____, HIV ____; exposto: HIV ____, anti-HBs ____ (susceptível?), HBsAg/anti-HCV ____.
- Conduta: lavagem local; PEP HIV (TDF+3TC+DTG) iniciada às ____ (< 72h?); HBV: vacina ____ + IGHAHB ____; HCV: monitorização.
- Notificado ao SINAN; retorno agendado (4 sem; testes em 1 e 3 meses).

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é o intervalo máximo para iniciar a PEP para HIV após exposição ocupacional?

- A) 24 horas
- B) 72 horas
- C) 1 semana
- D) 2 semanas
- E) Não há limite

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o esquema preferencial de PEP para HIV e sua duração?

- A) Zidovudina isolada por 14 dias
- B) Tenofovir + Lamivudina + Dolutegravir por 28 dias
- C) Dolutegravir isolado por 7 dias
- D) Apenas observação
- E) Aciclovir por 28 dias

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual dos três vírus tem o MAIOR risco de transmissão após acidente perfurocortante?

- A) HIV (~0,23%)
- B) Hepatite B (23-62%)
- C) Hepatite C (~2,2%)
- D) Todos têm o mesmo risco
- E) Nenhum é transmissível

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Profissional suscetível (anti-HBs negativo, esquema incompleto) exposto a fonte HBsAg positivo. Qual a conduta?

- A) Apenas observação
- B) Vacina contra hepatite B + imunoglobulina anti-hepatite B (IGHAB 0,06 mL/kg IM)
- C) Antibiótico
- D) Tenofovir isolado
- E) Nenhuma medida

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Sobre a profilaxia para hepatite C após exposição ocupacional, é correto:

- A) Usar imunoglobulina específica
- B) Não há profilaxia eficaz; faz-se testagem e monitorização para diagnóstico/tratamento precoce (cura > 95%)
- C) Vacinar imediatamente
- D) Iniciar antiviral profilático por 28 dias
- E) Nenhuma testagem é necessária

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A PEP para HIV deve ser iniciada em até 72h da exposição (quanto mais precoce, melhor); após esse prazo, não é indicada pela baixa eficácia, mantendo-se o acompanhamento sorológico.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O esquema preferencial é Tenofovir + Lamivudina + Dolutegravir (TDF + 3TC + DTG) por 28 dias.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A hepatite B tem o maior risco de transmissão após perfurocortante (23-62%, maior se fonte HBeAg+); HIV ~0,23% e HCV ~2,2%.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Exposto suscetível com fonte HBsAg+ recebe vacina contra hepatite B + imunoglobulina anti-hepatite B (IGHAB 0,06 mL/kg IM, idealmente < 24h).

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Não há profilaxia eficaz para hepatite C; testa-se fonte e exposto e monitora-se para diagnóstico e tratamento precoces, cujas taxas de cura superam 95%.

SM24
Suporte ao Plantão Médico